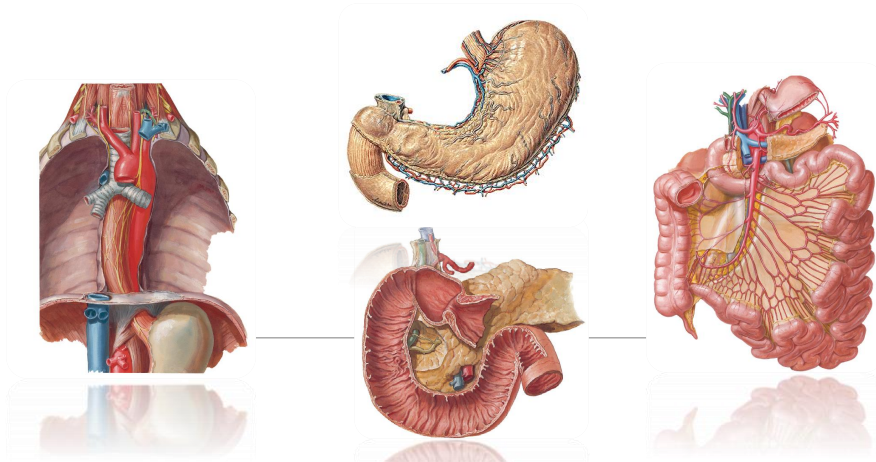


Anatomia sistema digestório: esôfago, estômago e intestino delgado



PROFA. DRA. PATRICIA CASTELUCCI
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA/ICB/USP
E-MAIL PCASTEL@USP.BR

Netter 3ª ed Sobotta 23aed...

Estratégias processo ensino-aprendizagem Método Teórico-prático

“Minuto de Reflexão”

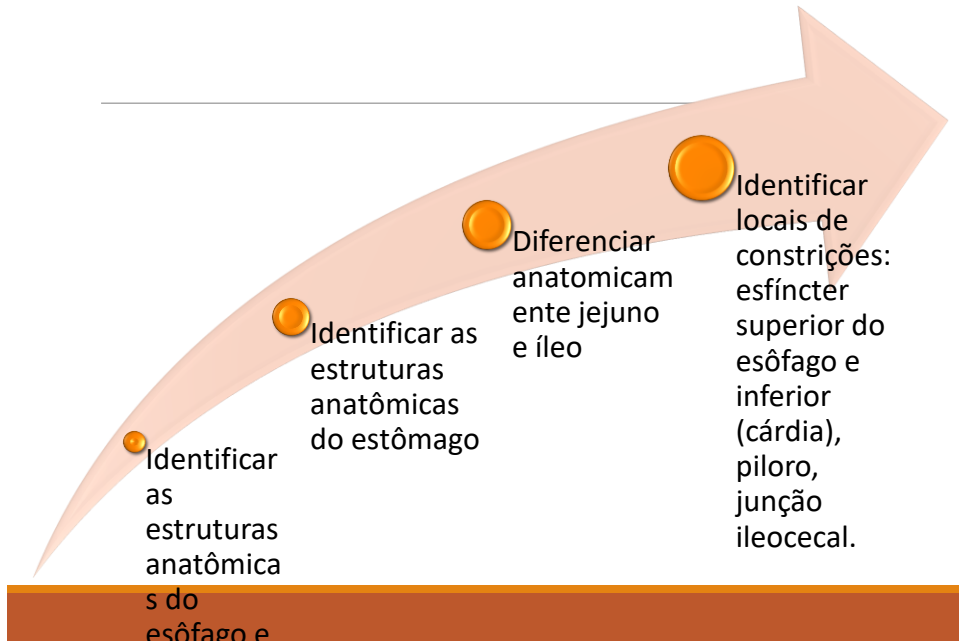
Desafio Anatômico com Mentimeter

Aula teórica-prática

Estudo na aula prática em grupos

Alcançar o objetivo do conhecimentos
anatômicos

Objetivos da aula

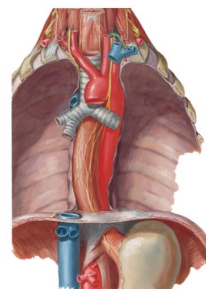
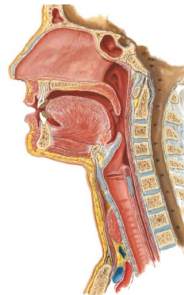


Sistema Digestório (*apparatus digestorius*)

Responsável mastigação, ingestão, digestão e absorção dos alimentos e eliminação dos resíduos.

Constituído por tubo músculo –membranoso

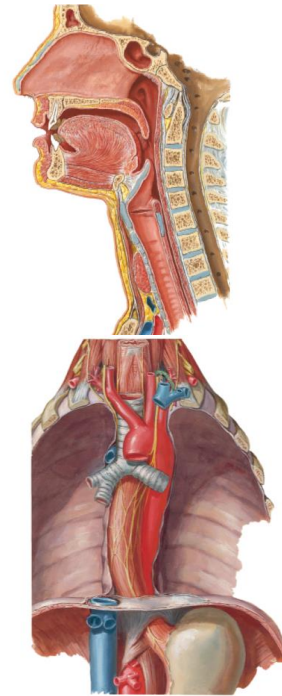
início na cabeça, passa pelo pescoço, tórax, abdome e termina no orifício anal.



Esôfago

Tubo de conexão entre a faringe e o estômago, atravessa tórax e abdômen

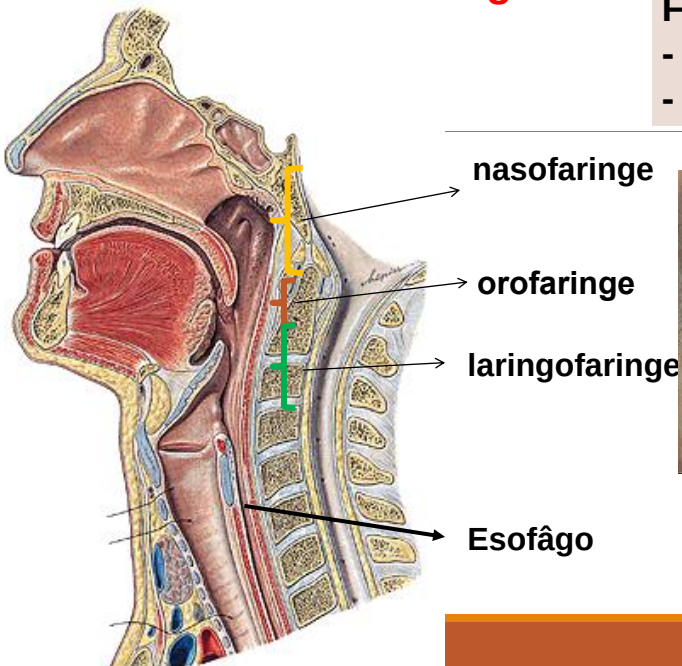
Tubo: 23-25 cm comprimento com 2cm de diâmetro



Netter, 3ª ed.

Faringe

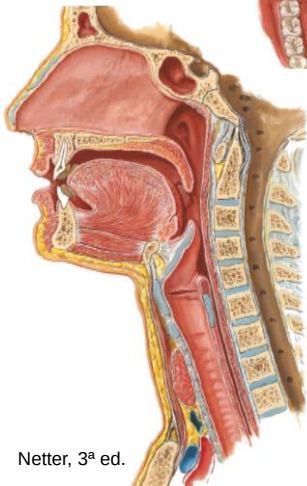
Funções
- véu palatino
- Epiglote



Sobotta, 23 edição

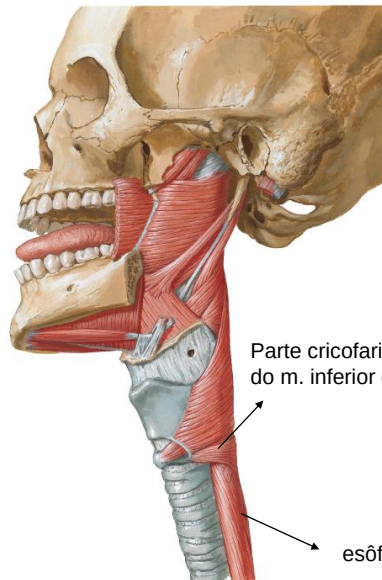
Funções
- véu palatino
- Epiglote

Músculo da úvula
m. Palatofaríngeo
m. Palatoglosso
m. Tensor do véu palatino
m. Levantador do véu palatino



Netter, 3ª ed.

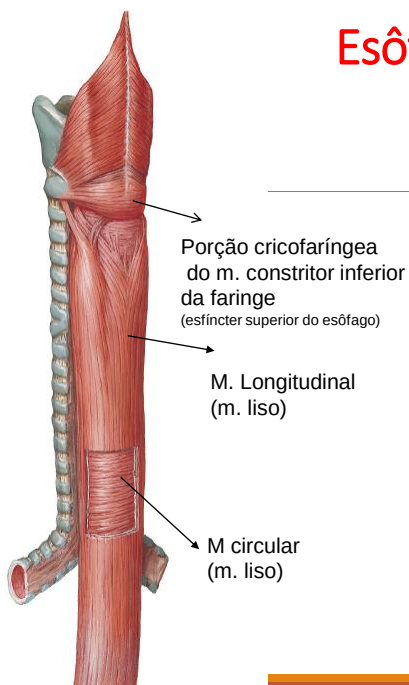
Faringe



Parte cricofaríngea
do m. inferior da faringe

esôfago

Esôfago



Porção cricofaríngea
do m. constritor inferior
da faringe
(esfíncter superior do esôfago)

M. Longitudinal
(m. liso)

M circular
(m. liso)

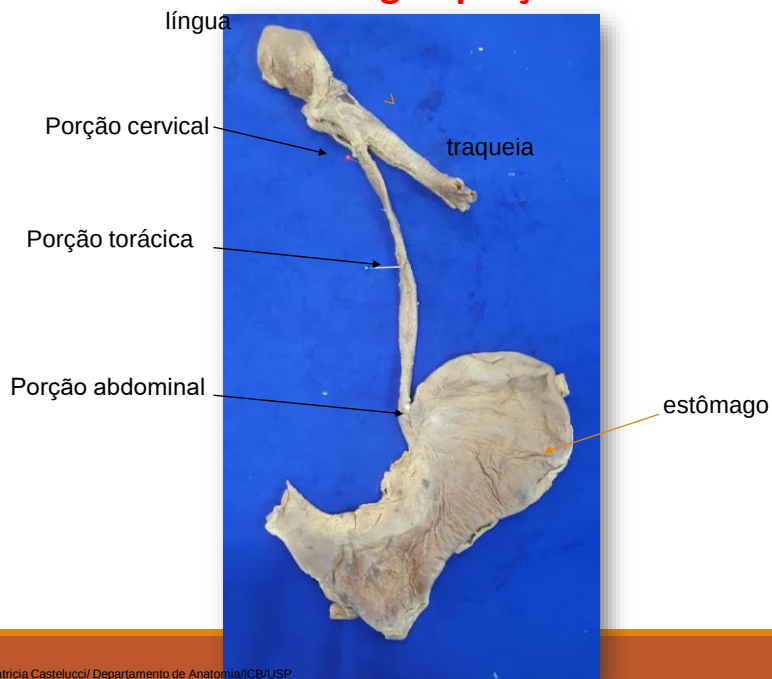
Tubo muscular

Músculo estriado esquelético porção
inicial (+/-1/3), músculo liso com m.
estriado (na metade), 1/3 final
músculo liso

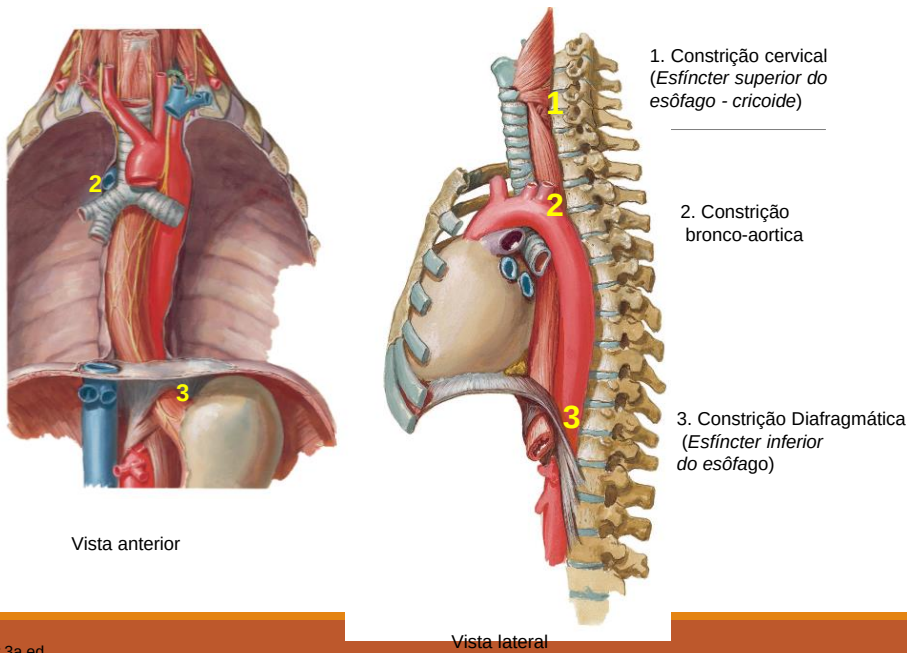
Movimentos de peristalse da
musculatura da sua parede circular e
longitudinal.

Netter, 3ª edição

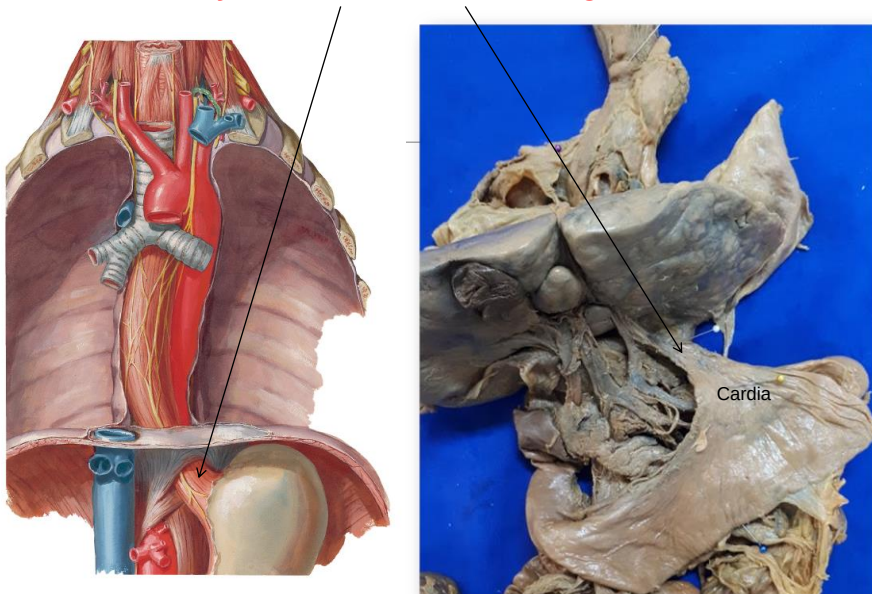
Esôfago - porções



Estreitamentos do esôfago

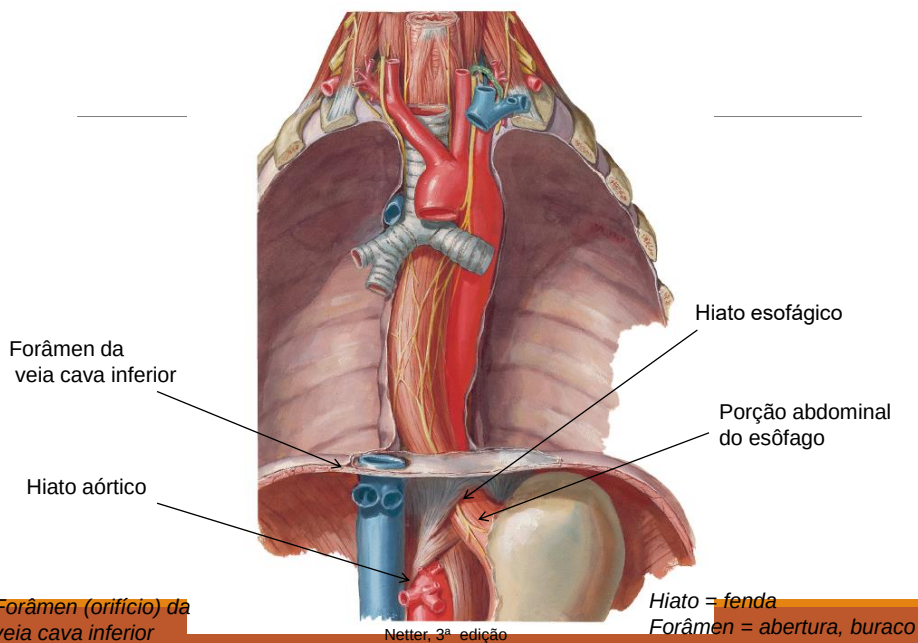


Porção Abdominal do esôfago



Netter 3a ed. Foto: Patricia Castelucci Depto de Anatomia/IC/USP

Hiato esofágico – porção abdominal do esôfago

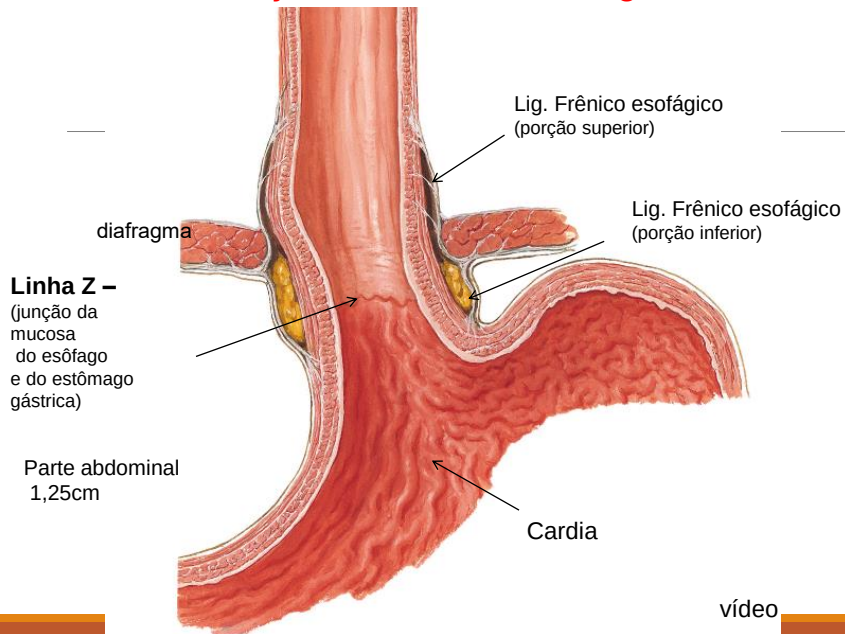


Doença de Chagas – perda dos neurônios entéricos



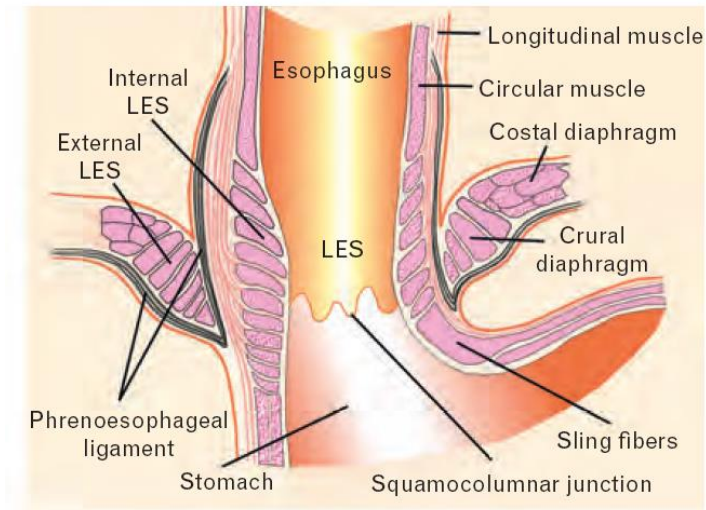
Furness, 2012

Porção abdominal do esôfago T10

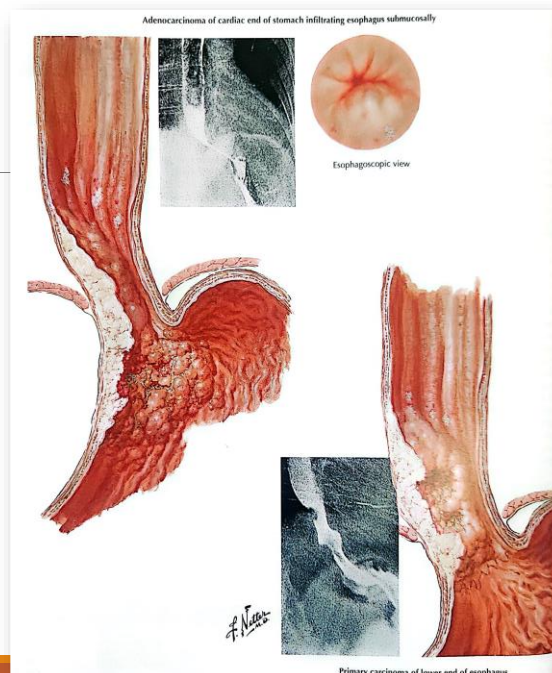


Netter, 3 edição,

vídeo



Mittal R, 2013.
Current Op Gastroenterol 2013 29: 421-430.



Caso clínico

Homem, 58 anos, tabagista, Referiu-se as disfagia (dificuldade de engolir, afetando a passagem de alimentos ou líquidos da boca para o estômago). Dificuldade para engolir primeiro comida sólidas , depois pastosas e depois líquidas. Indicada Endoscopia alta, foi detectada tumor no esôfago.

A) Os tumores esofágicos desenvolvem na porção abdominal do esôfago. Cite as porções do esôfago.

B) Conhecer as constrições esofágicas é fundamental para Na endoscopia alta pode ocorrer lesões. Cite as principais relação anatômicas com as constrições esofágicas.



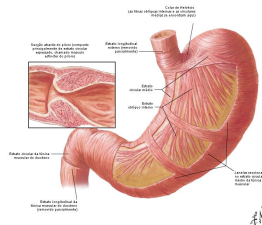
<https://drpaulopittelli.com.br/wp-content/uploads/2013/02/cancer-esofago.jpg>

Estômago – características

formato letra J

Músculo liso circular e longitudinal

formato muda de acordo com o biotipo da pessoa, respiração, posição da pessoa



PARTES DO ESTÔMAGO

1 Cárdia
(circunda o óstio cárdico)
Incisura angular =
entre corpo e região pilórica

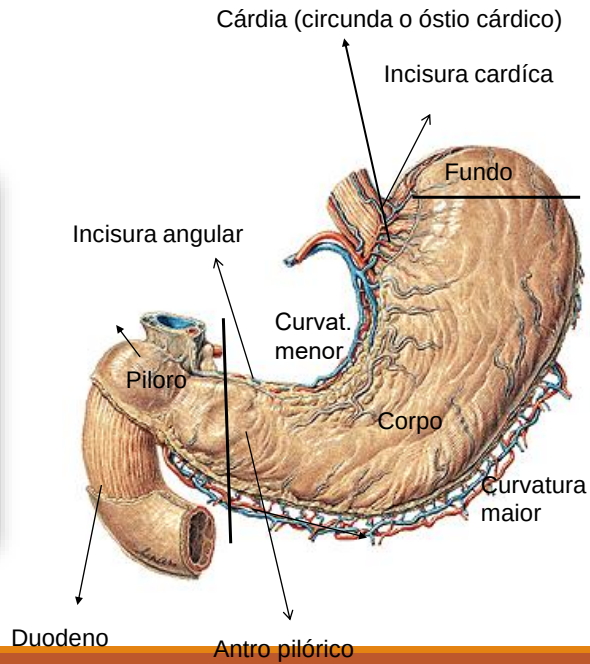
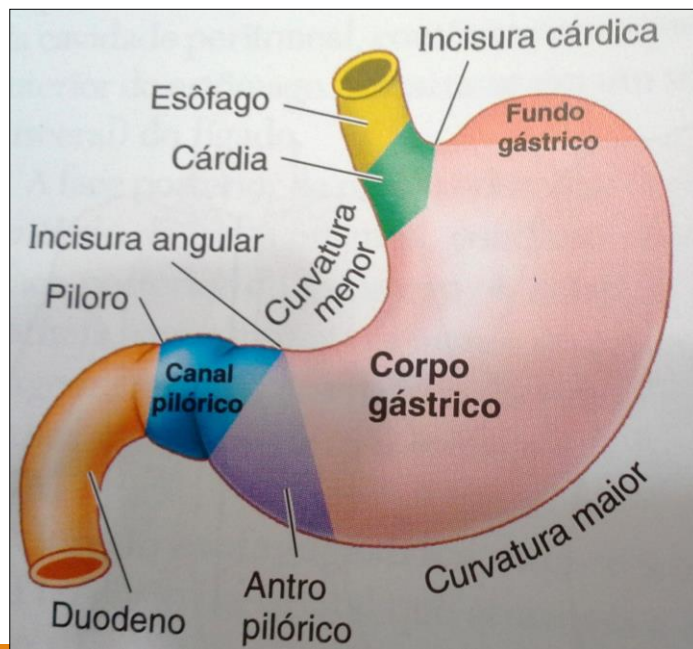


Foto: Prof Patrícia Castelucci/ Departamento de Anatomia/ICB/USP

Sobotta, 23 edição



Moore, 5 edição

Estômago – porções

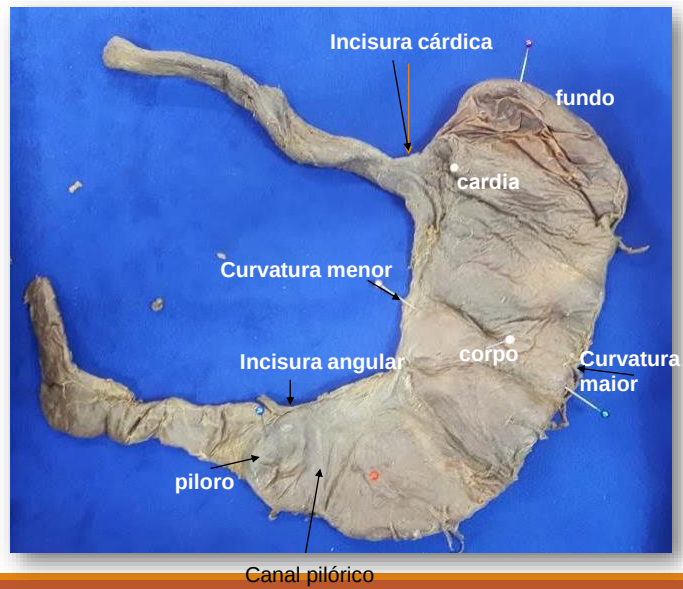


Foto: Prof Patricia Castelucci/
Departamento de Anatomia/ICB/USP

Estômago aberto

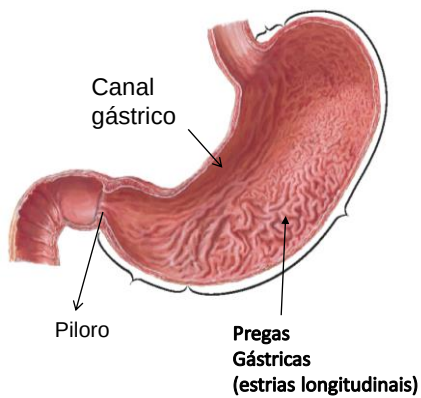
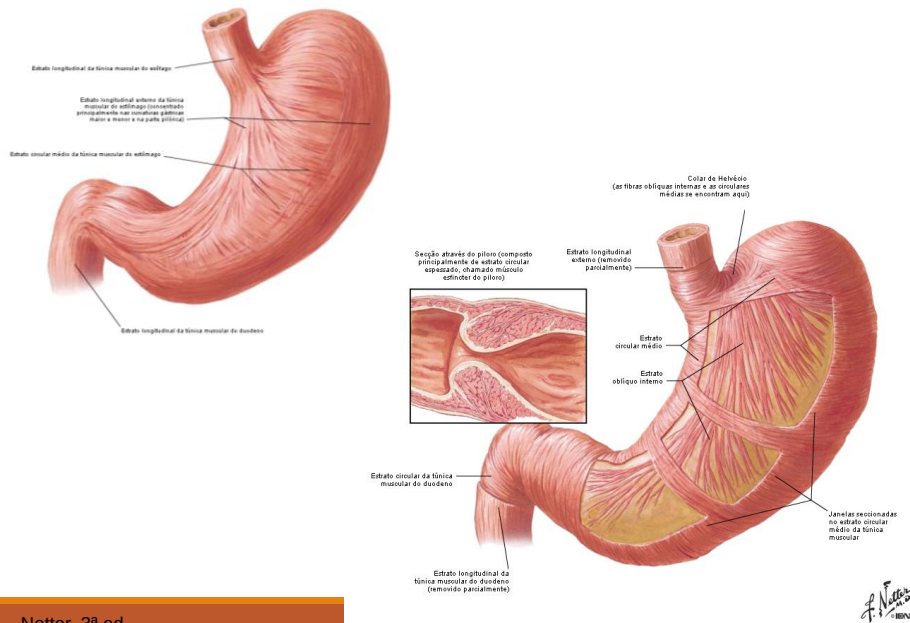


Foto: Prof Patricia Castelucci/ Departamento de Anatomia/ICB/USP; Netter 3ª ed.

Músculos- Estômago



Netter, 3ª ed.

Funções do estômago

Reduzir o bolo alimentar em massa semiflúida chamada: quimo

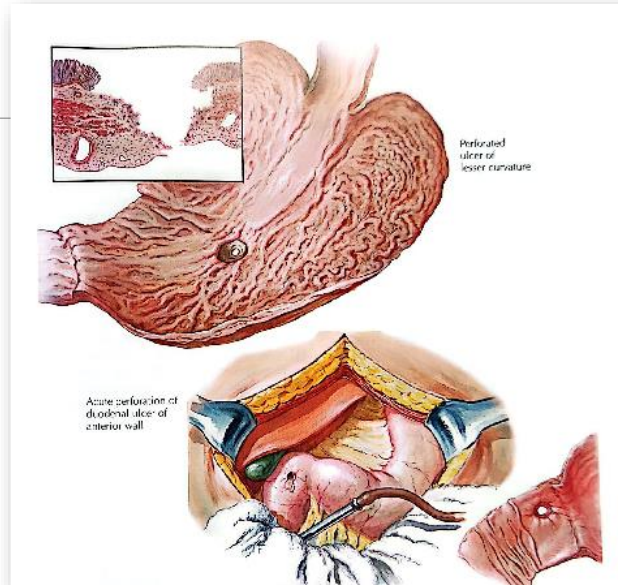
Função: reservatório transitório: alimento parcialmente digerido

vídeo

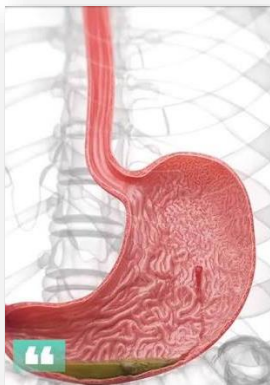


Foto: Prof Patricia Castelucci/ Departamento de Anatomia/ICB/USP

Caso clínico – Úlcera gástrica perfurada



Caso clínico – Úlcera gástrica perfurada



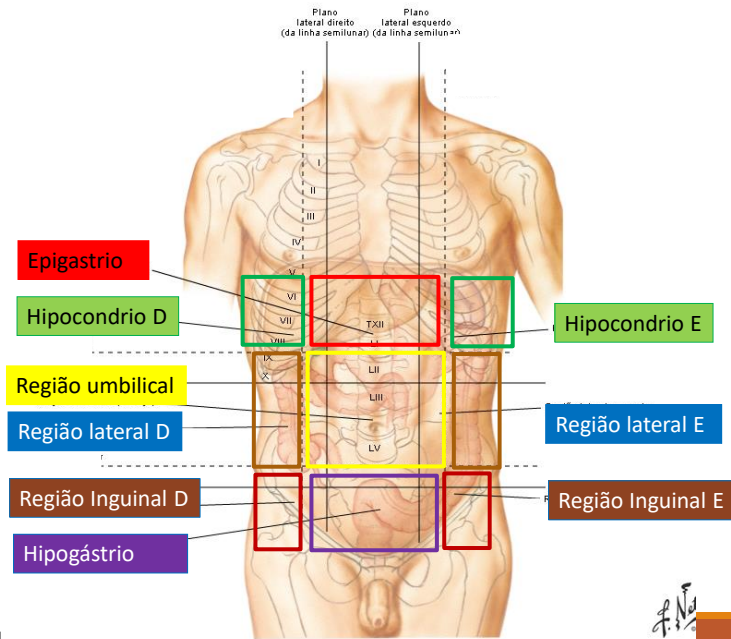
Homem, 73 anos, deu entrada no serviço de emergência apresentado dor intensa no epigástrico após utilização de altas doses de medicação anti-inflamatória não hormonal. Para tratamento de artrite no joelho..

Rotina radiológica identificou possível pneumoperitônio. Foi feito exame físico: abdômen distendido, dor a palpação. Então foi feita laparotomia exploratória de urgência. Foi identificado ulcera gástrica perfurada. Foi realizado sutura da ulcera, vagotomia troncular e piloroplastia.

A)O Conhecimento prévio das regiões gástricas é fundamental para o tratamento cirúrgico. De lesões estomacais. Delimite as porções do estômago e suas curvaturas.

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GkT6M8BtUpOxL4dYVW75BC4K233yX0MnyW7T6G2P5Q5m4q7Q&usqp=CAU>

Planos abdominais



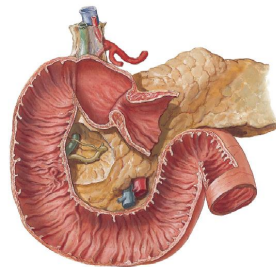
Netter, 3ª ed.

Intestino Delgado

Constituem:
duodeno, jejuno e íleo

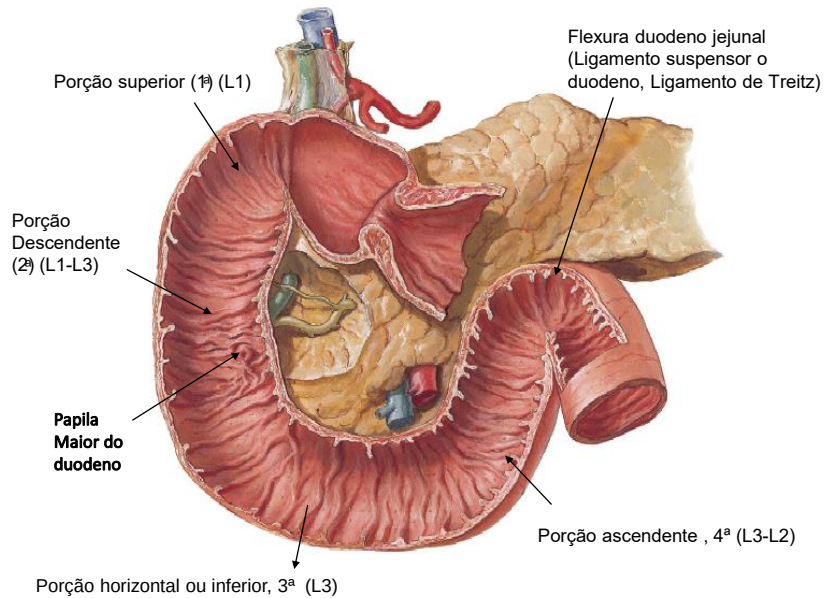
cerca de 7 m, varia entre 6 a 8 m

Completar a digestão,
absorção e a secreção.



Netter, 3ª ed..

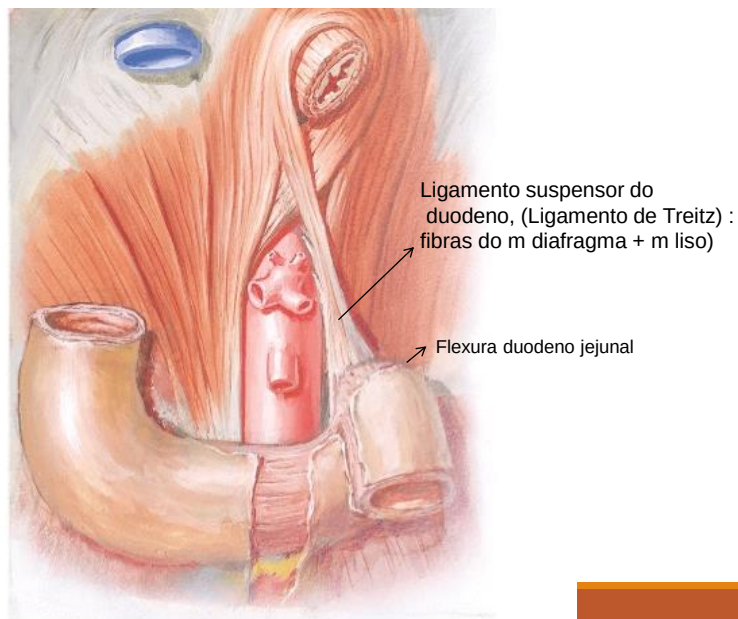
Duodeno – porções



Netter, 3ª ed.

Partes do Duodeno: 25cm, forma de C ao redor da cabeça do pâncreas

Ligamento suspensor do duodeno - Ligamento de Treitz



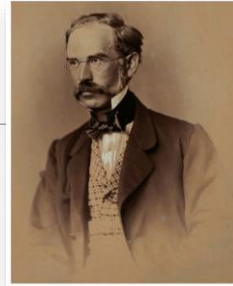
Netter, 3ª ed.

Václav (Wenzel) Treitz - Ligamento de Treitz

Em **1853**, em seu tempo "polonês", Treitz publicou um Estudo anatómico da Suspensão da parte ascendente do duodeno na transição para o jejuno.

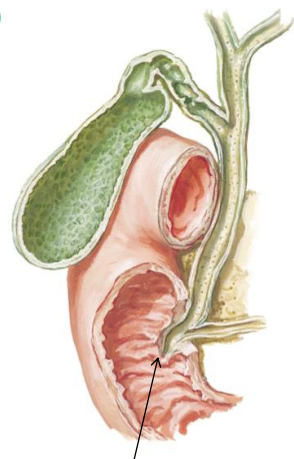
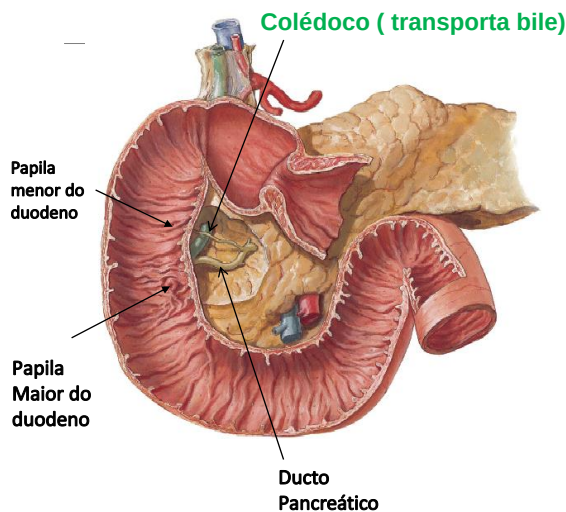
De acordo com a visão tradicional, o tecido conjuntivo conectava essa flexão ao pâncreas, mas Treitz observaram que a localização não mudou após a remoção do pâncreas.

Ele encontrou uma estrutura separada: no lado superior, na "curva externa" da flexura duodenojejunalis, as fibras musculares lisas nascem, espalhadas por alguns centímetros. Essas fibras musculares se acumulam, se juntam em uma estrutura mais estreita, semelhante a um tendão, e terminam no tecido conjuntivo ao redor do tronco celiaco. Treitz chamou o músculo de "musculus suspensorius duodeni".



J Surg. 1985; 9: 361-6 revisão., Netter 3ª ed..

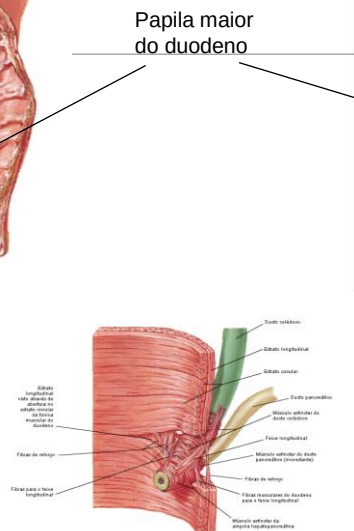
Papila Maior do duodeno – 2a porção do duodeno



Papila Maior do duodeno
(Ampola de Vater - Esfincter de Oddi)

Netter, 3ª ed.

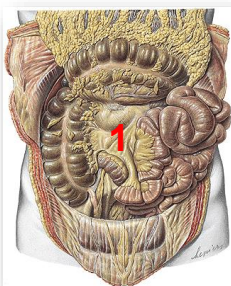
Papila Maior do duodeno



Papila Maior do duodeno (Ampola de Vater - Esfincter de Oddi)

Foto: Prof Patricia Castelucci/ Departamento de Física

Características jejuno e íleo



Jejuno 2/5, e o íleo 3/5 do intestino delgado

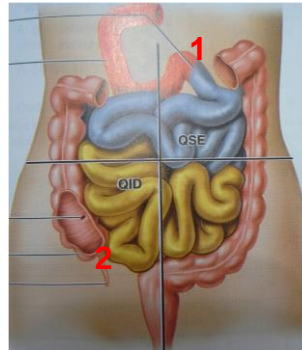
1 Mesentério: prega peritoneal que fixa o jejuno e íleo

Peritônio: membrana serosa de parede dupla que forra a parede abdominal (peritônio parietal) e vísceras (peritônio visceral)

Características jejuno e íleo

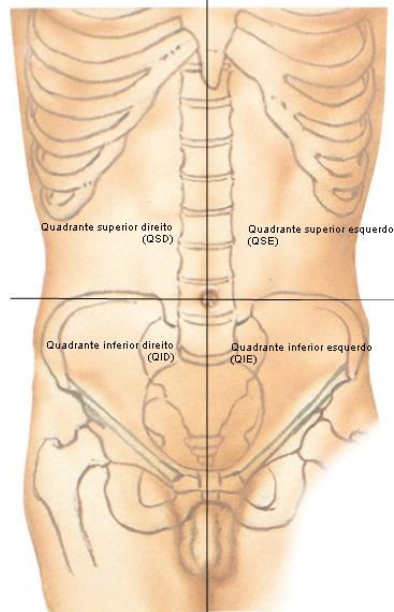
1 Inicia na junção duodeno jejunal

2 Término:
na junção íleo cecal.
Juntos tem 6 a 7 m.

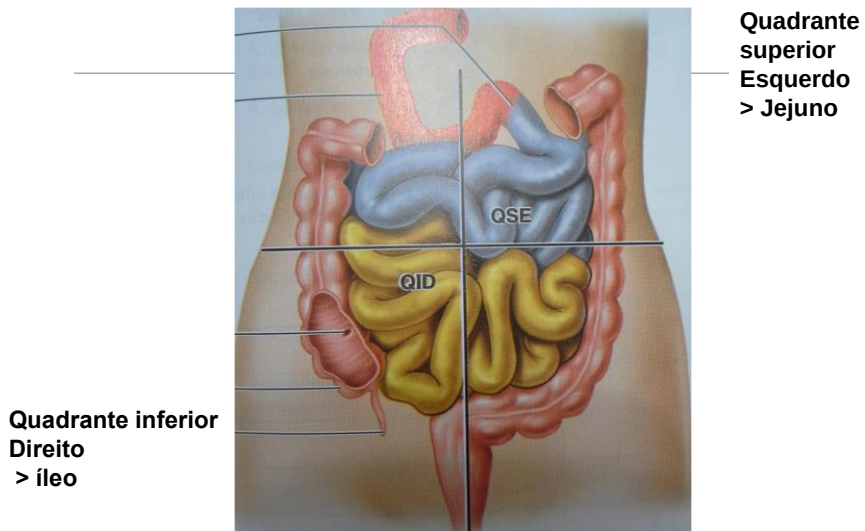


Netter, 3ª ed.;

Planos abdominais

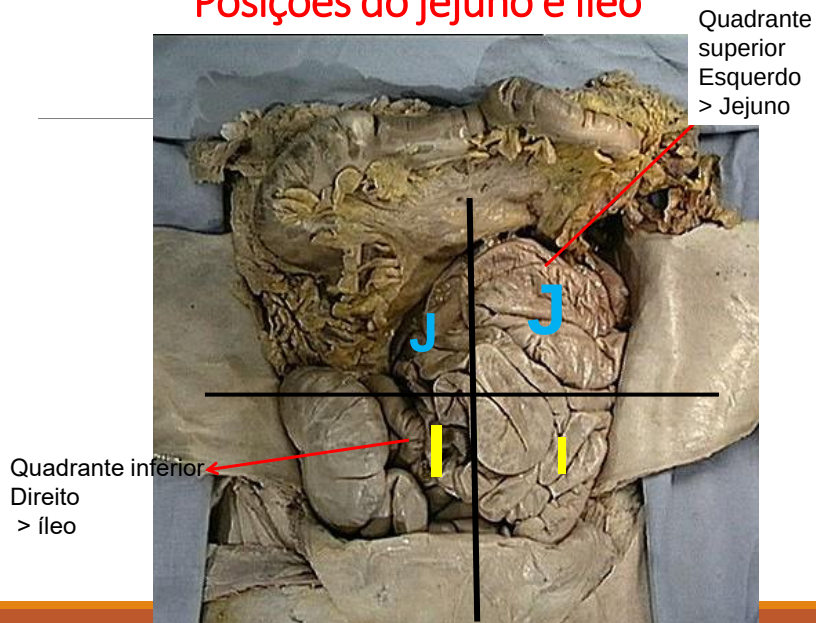
Netter, 3^a ed.

Posições do jejuno e íleo



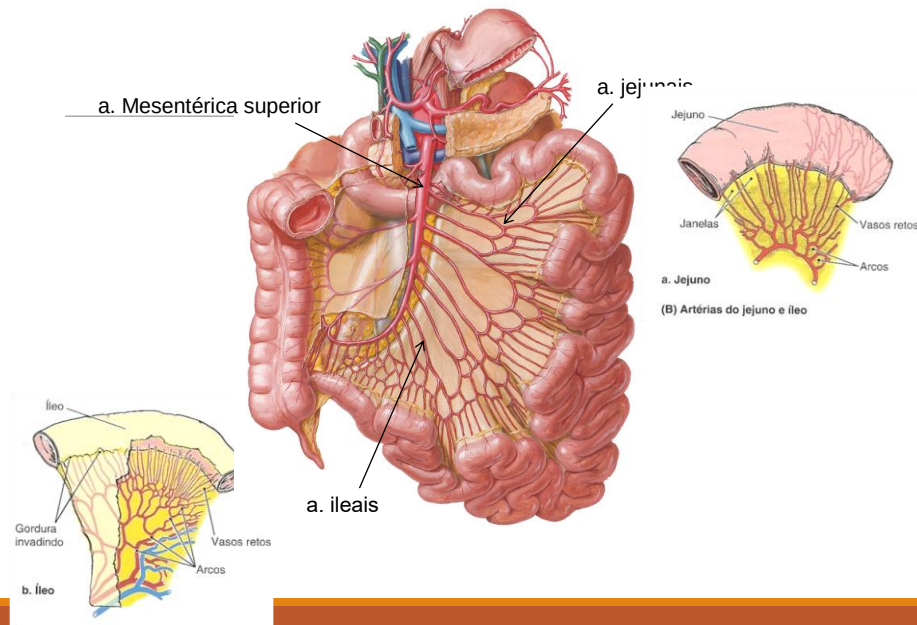
Netter, 4 edição

Posições do jejuno e íleo



Netter, 4 edição

Características íleo e jejuno



Netter, 3ª ed. Morre, 6ª ed.

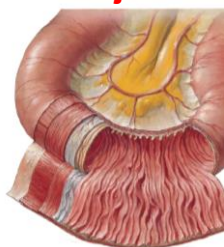




Vasos retos
curtos
- íleo

Características jejuno e íleo

Jejuno

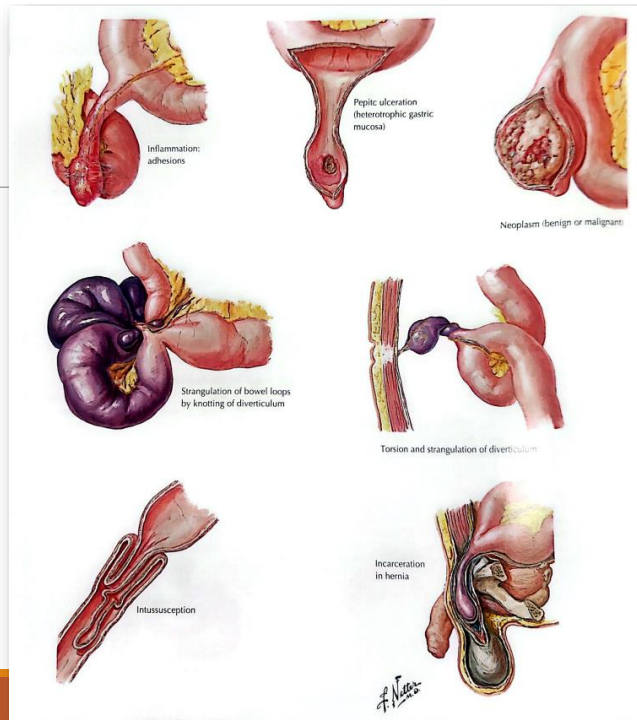


Íleo

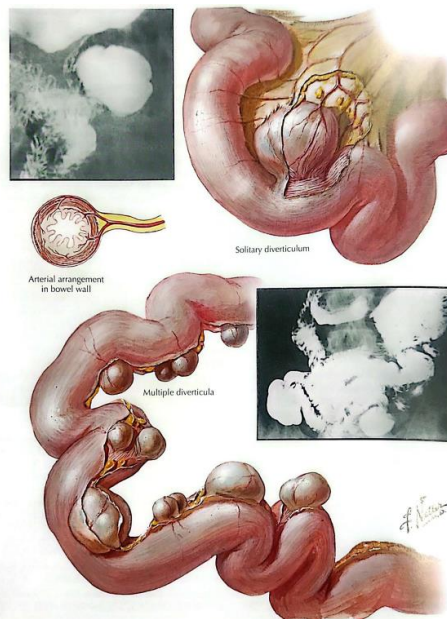


características	jejuno	íleo
cor	Vermelho-vivo	Rosa- claro
Calibre	2-4cm	2-3cm
Parede	espessa	fina
vascularização	maior	menor
Vasos retos	longos	curtos
Arcos	Algumas alças grandes	Muitas alças curtas
Pregas circulares	muitas	Baixas e espessas

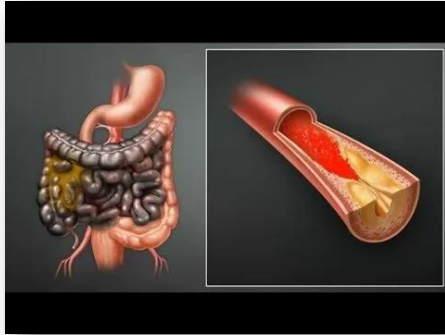
Netter, 3ª ed.



Divertículos íleo



Caso clínico



Mulher, 57 anos, tabagista de 1 maço de cigarro/dia, procurou serviço de emergência apresentando dor nos quadrantes abdominais inferiores com início e piora nos 12 horas. Exame físico, apresentou abdômen distendido, tenso doloroso. Após Tomografia computadorizada, foi realizada laparotomia exploratória. Durante a cirurgia foi confirmada a isquemia mesentérica. A isquemia mesentérica apresenta comprometimento arterial do intestino delgado

A) Cite as diferenças anatômicas entre jejuno e íleo.

Objetivos da aula



Bibliografia

DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. - *Anatomia humana sistêmica e segmentar*. 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Atheneu.

MOORE, K.L. – *Anatomia orientada para clínica*. 6a ed., Rio de Janeiro, Guanabara Koogan.

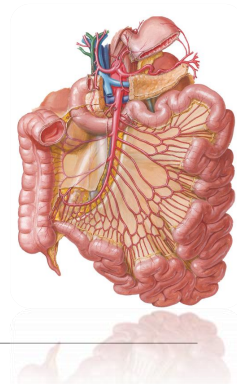
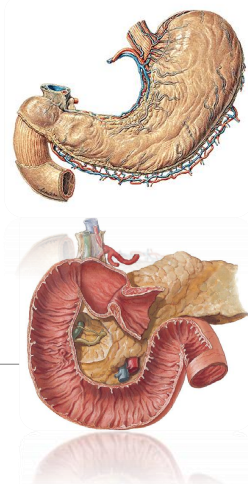
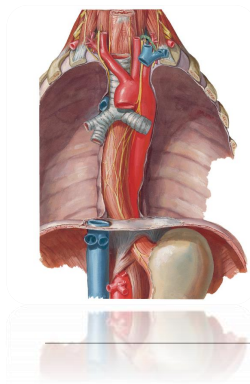
DRAKE, R.L.; VOGL, A.W; MITCHELL, A. W.M. – *Gray's Anatomia para estudantes*, 2a ed., Elsevier.

SOBOTTA, J.; BECHER, H. - *Atlas de anatomia humana*. 23ª ed., Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, Vols. I, II e III.

SCHÜNKE, M.; SCHULTE, E.; SCHUMAKER, U.; VOLL, M.; WESKER, K.. - *PROMETEUS, Atlas de Anatomia*, Guanabara Koogan.

NETTER, F. - *Atlas de Anatomia*, 3a ed., Elsevier.

Muito Obrigada!



PROFA. DRA. PATRICIA CASTELUCCI
DEPARTAMENTO DE ANATOMIA/ICB/USP

E-MAIL PCASTEL@USP.BR

PATRICIA.CASTELUCCI@FM.USP.BR